

Les moyens de défense de l'arbre urinaire contre les infections sont :

- A. Des mictions fréquentes
- B. Le pH acide des urines
- C. La présence de polynucléaires phagocytaires dans les urines
- D. La forte osmolarité des urines
- E. La sécrétion par le rein d'anticorps protecteurs

Les bactéries habituellement responsables des infections urinaires communautaires sont :

- A- *Staphylococcus aureus*
- B- *Serratia marcescens*
- C- *Klebsiella pneumoniae*
- D- *Pseudomonas aeruginosa*
- E- *Escherichia coli*

Chez la femme jeune, les bactéries fréquemment responsables des infections urinaires communautaires sont :

- A- *Staphylococcus saprophyticus*
- B- *Staphylococcus aureus*
- C- *Serratia marcescens*
- D- *Pseudomonas aeruginosa*
- E- *Escherichia coli*

En Tunisie, la résistance des entérobactéries uropathogènes :

- A- Est > 50% pour l'amoxicilline
- B- Est > 25% au cotrimoxazole
- C- Est < 5% aux carbapénèmes
- D- Est < 10% aux C3G
- E- Est < 10% aux fluoroquinolones

Les entérobactéries BLSE sont résistantes :

- A- Aux C3G
- B- Aux céfamycines.
- C- A l'ertapénème
- D- Aux pénicillines.
- E- A l'imipénème

Les facteurs de risque d'acquisition d'une E-BLSE sont :

- A- Séjour prolongée dans le Sud-Est Asiatique
- B- Consommation de fluoroquinolones remontant à 10 mois
- C- Miction par sondage intermittent
- D- Prise d'amoxicilline – acide clavulanique remontant à deux mois
- E- Séjour récent à l'hôpital

Les facteurs de risque de résistance aux FQ sont :

- A- Genre féminin
- B- Cystites récidivantes
- C- Sondage à demeure
- D- Prise de céfixime remontant à deux mois
- E- Age > 45 ans

Les facteurs favorisant la survenue d'une infection urinaire sont :

- A. Sexe masculin
- B. Diabète
- C. Sondage vésical
- D. Paraplégie
- E. Ménopause

Les facteurs favorisant les IU chez la femme sont :

- A- La brièveté de l'urètre
- B- La proximité du méat urétral et de l'anus
- C- La fréquence de la pathologie ovarienne
- D- La constipation
- E- La grossesse

Un homme âgé de 50 ans, diabétique, vous consulte pour BM, PK et fièvre non chiffrée avec des frissons. Il vous rapporte que les urines ont un aspect trouble. Examen : T° = 40°C, douleur à l'ébranlement des 2 fosses lombaires. Devant ce patient, les diagnostics à évoquer sont :

- A. Une cystite aiguë
- B. Une crise de colique néphrétique
- C. Une prostatite aiguë
- D. Une colonisation urinaire
- E. Une pyélonéphrite aiguë

Les facteurs de risque de complication d'une infection urinaire sont :

- A. Sexe masculin
- B. Diabète
- C. Age > 65 ans
- D. Grossesse
- E. Clearance de la créatinine < 60 ml/min

Une PNA chez une femme âgée de 40 ans est considérée compliquée en cas :

- A. De néphrite focale
- B. De la Présence d'un abcès de 3 cm
- C. De la présence d'une lithiase non obstructive sur le trajet urétéral
- D. De neutropénie
- E. De phlegmon périnéphrétique

Chez un homme consultant pour une fièvre associée à une pollakiurie, vous évoquez une prostatite devant :

- A. Une douleur pelvienne
- B. La présence d'une orchi-épididymite
- C. Une rétention aiguë d'urines
- D. La présence d'une hématurie
- E. Une dysurie

Chez une femme de 70 ans, la PNA est considérée grave en cas :

- A. D'une PA systolique à 80 mmHg
- B. D'isolement d'E. coli BLSE
- C. D'un taux de PNN à 1200/mm³
- D. De la survenue au décours d'une cystoscopie
- E. De diabète

Une leucocyturie sans germes peut se voir au cours :

- A- D'une lithiase vésicale.
- B- D'une tuberculose urinaire.
- C- D'un abcès du rein.
- D- D'une maladie polykystique du rein
- E- D'un cancer de la prostate.

Un homme âgé de 65 ans, diabétique, insuffisance rénale, consulte pour une IU récidivante.

Les examens radiologiques pouvant être réalisés sont :

- A- Une cystographie isotopique.
- B- Une urétrocystographie rétrograde.
- C- Une scintigraphie rénale DMSA.
- D- Un uroscanner.
- E- Une urographie intraveineuse.

L'antibiothérapie de première intention d'une cystite simple repose sur :

- A. Nitrofurantoïne
- B. Céfotaxime
- C. Céfixime
- D. Fosfomycine
- E. Ciprofloxacine

Une femme âgée de 50 ans vous consulte pour BM, PK et fièvre non chiffrée avec des frissons. Elle vous rapporte que les urines ont un aspect trouble. Examen : $T^{\circ} = 40^{\circ}\text{C}$, douleur à l'ébranlement des 2 fosses lombaires. L'antibiothérapie de première intention repose sur :

- A. Gentamicine
- B. Céfotaxime
- C. Cotrimoxazole
- D. Céfotaxime + gentamicine
- E. Ciprofloxacine

Une femme âgée de 30 ans, enceinte de 15 SA, vous consulte pour BM, PK et fièvre non chiffrée avec des frissons. Elle vous rapporte que les urines ont un aspect trouble. Examen : $T^{\circ} = 40^{\circ}\text{C}$, douleur à l'ébranlement des 2 fosses lombaires. L'antibiothérapie de première intention repose sur :

- A. Gentamicine
- B. Céfotaxime
- C. Cotrimoxazole
- D. Céfotaxime + gentamicine
- E. Ciprofloxacine

Une patiente de 26 ans vous consulte pour une dysurie évoluant depuis 24 heures sans fièvre ni douleurs lombaires. Vous posez le diagnostic d'une cystite:

- A- Le traitement repose sur l'antibiothérapie après ECBU.
- B- Le traitement repose sur une antibiothérapie d'une durée minimale de 5 jours.
- C- L'échographie rénale doit être programmée.
- D- Une grossesse doit être éliminée.
- E- Il faut rechercher un facteur favorisant.